

Przodopochylenie miednicy

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Nauka ustawienia miednicy bliżej pozycji neutralnej, poprawa kontroli mięśni brzucha i pośladków oraz tolerancji wyprost biodra.

Uwaga kliniczna
Samo przodopochylenie nie jest chorobą. Ćwiczymy wtedy, gdy to ustawienie wiąże się z bólem, przeciążeniem lub słabą kontrolą ruchu.

1 JOGA 1 Niski wykrok z podwinięciem miednicy - progresja

Z kłku wysuń jedną stopę do przodu. Delikatnie podwiń miednicę „ogon pod siebie”, napnij pośladek nogi zakroczonej i przesun tułów minimalnie do przodu. Nie rób przeprostu lędźwi. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Rozciąganie powinno być z przodu biodra nogi zakroczonej. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Usiądź w kierunku pięt i wydłuż plecy, wyciągając ręce przed siebie. Oddychaj do dolnych żeber i rozluźnij odcinek lędźwiowy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj pośladków na siłę do pięt. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Tyłopochylenie miednicy w leżeniu - progresja

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Na wydechu delikatnie zbliż dolne żebra do miednicy i spłaszcz lędźwie do podłoża. Wróć do neutralnej pozycji bez odrywania stóp. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ma pochodzić z miednicy, nie z mocnego napinania szyi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Most z pauzą 2-3 s

Najpierw delikatnie ustaw miednicę neutralnie lub lekko podwiń, potem unieś biodra. Utrzymaj żebra „nad miednicą”, bez wypychania brzucha w górę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Poczuj pośladki, nie tylko lędźwie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył z kontrolą tułowia - progresja

Stań prosto, zrób krok w tył i zejźdź w dół. Utrzymuj żebra nad miednicą, brzuch lekko aktywny i pośladek nogi podporowej napięty. Wróć do stania. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie pozwalaj, aby miednica uciekała w duży przeprost lędźwiowy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.